# Historia Clínica del Paciente

**María González** | 40 años | Femenina **Fecha:** 2026-03-28 | **Estado:** Completa

---

## Datos Personales

| Campo | Valor |
|---|---|
| Edad | 40 años (FN: 1984-03-15) |
| Ocupación | Contadora en estudio contable (15 años) |
| Categoría | Administrativa/Profesional |
| Exposición | Pantalla >10 hs/día, estrés fiscal |

---

## Motivo de Consulta

**Cefalea crónica**

---

## Enfermedad Actual

Paciente femenina de 40 años, contadora con alta carga laboral visual, que consulta por cefalea de 3 meses de evolución, de aparición vespertina y predominio en días de semana.

**SEMIOLOGÍA DETALLADA (ALICIADO):** La cefalea inició de forma insidiosa hace 3 meses, presentándose casi a diario. Se localiza en la región nucal y se irradia bilateralmente hacia las sienes. El carácter es opresivo. La intensidad habitual es 6-7/10, alcanzando 8/10 en los episodios más severos, momento en el cual le impide la concentración. Los episodios duran varias horas, típicamente toda la tarde si no media tratamiento. Se desencadena por la exposición prolongada a la pantalla de la computadora durante la jornada laboral y mejora significativamente durante los fines de semana. Se atenúa de forma parcial y transitoria con ibuprofeno. Se asocia a fotofobia y náuseas ocasionales en picos de máxima intensidad.

**NEGATIVOS PERTINENTES:** Niega vómitos y fonofobia. No se interrogaron explícitamente otros signos de alarma como cefalea en trueno, cefalea que la despierte del sueño, déficit neurológico focal, rigidez de nuca, fiebre o pérdida de peso.

**EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO:** Mantiene un patrón de frecuencia casi diario en los últimos 3 meses. Se automedica con ibuprofeno 400mg 2-3 veces por semana, con alivio parcial. Refiere menor efectividad con paracetamol.

| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Cronología | 3 meses, inicio insidioso |
| Severidad | 6-8/10 EVA |
| Síntomas asociados | Fotofobia, náuseas ocasionales |
| Factores agravantes | Pantalla prolongada, estrés laboral |
| Factores aliviantes | Descanso (fines de semana), ibuprofeno (parcial) |

| | |
|---|---|
| Tratamientos probados | Ibuprofeno 400mg 2-3x/sem, Paracetamol 500mg |

## Antecedentes Personales

### Patológicos

- HTA diagnosticada hace 2 años, en tratamiento con Enalapril 10mg/día con **adherencia irregular**
- Alergia a Penicilina con **reacción anafiláctica** en la infancia

### Fisiológicos

- G1P1 (Cesárea en 2015)
- Ciclos menstruales regulares (cada 28-30 días)

### Estilo de vida

- Sedentarismo (sin actividad física)
- Café: 3-4 tazas/día
- Alcohol: social y ocasional
- No tabaquista
- Sueño: 6-7 horas, dificultad ocasional para conciliación

---

## Alergias

**PENICILINA — Anafilaxia confirmada**

Reacción en infancia: rash generalizado, angioedema labial, disnea. Requirió atención de urgencia.
**Grupo: Beta-lactámicos.**

---

## Medicación Actual

| Medicamento | Dosis | Frecuencia | Adherencia |
|---|---|---|---|
| Enalapril | 10mg | 1x/día (mañana) | Irregular |
| Ibuprofeno | 400mg | 2-3x/semana | Automedicación |
| Paracetamol | 500mg | Ocasional | Automedicación |

---

## Antecedentes Familiares

- **Padre:** Fallecido a los 65 años por IAM. Antecedente de HTA.
- **Madre:** Viva, 70 años. HTA en tratamiento.
- **Hermano:** 38 años, sano.
- **Abuela materna:** Diabetes Mellitus tipo 2.

## Revisión por Sistemas

| Sistema | Hallazgos |
|---|---|
| **Cardiovascular** | Niega palpitaciones, disnea y edemas |
| **Respiratorio** | Niega tos y disnea |
| **Digestivo** | Acidez ocasional asociada al consumo de ibuprofeno |
| **Genitourinario** | Niega disuria. Ciclos regulares |

---

# ANÁLISIS CLÍNICO — AutaMedica IA

### Cruces clínicos entre secciones

**[CRITICAL]** Antecedente de reacción anafiláctica a Penicilina. Requiere señalización prominente.

**[HIGH]** El consumo de analgésicos (ibuprofeno) ocurre 2-3 veces por semana (8-12 días/mes) durante 3 meses. Este patrón se aproxima al criterio temporal descrito para la cefalea por uso excesivo de medicación.

**[HIGH]** Paciente con HTA y cefalea de reciente comienzo. La adherencia irregular al enalapril podría influir en el control tensional y ser un factor contribuyente.

**[MEDIUM]** La paciente reporta acidez gástrica específicamente asociada al consumo frecuente de ibuprofeno.

**[MEDIUM]** Factores de estilo de vida como sedentarismo, alto consumo de cafeína (3-4/día), estrés laboral y exposición prolongada a pantallas pueden ser contribuyentes o desencadenantes de la cefalea.

---

### Alertas de seguridad

| Flag | Fuente | Relevancia |
|---|---|---|
| Alergia a Penicilina con anafilaxia | Alergias | CRÍTICA |
| Adherencia irregular a Enalapril | Medicamentos | ALTA |
| Uso frecuente de AINEs (2-3x/sem) | Medicamentos | ALTA |
| Padre fallecido por IAM a los 65 | Antecedentes familiares | ALTA |

---

### Cobertura semiológica (Argenté)

**Cubiertas:** Datos personales, Motivo de consulta, Enfermedad actual, Antecedentes personales, Antecedentes familiares, Hábitos y estilo de vida

**Débiles:** Interrogatorio neurológico extendido, Examen físico (limitación del formato)

### Datos no interrogados

- Cefalea en trueno o "peor cefalea de la vida"
- Cefalea que despierta del sueño
- Cefalea asociada a esfuerzo físico
- Déficit neurológico focal
- Rigidez de nuca
- Relación con el ciclo menstrual
- Progresión en frecuencia o intensidad

---

Documento confidencial — Ley 26.529 de Derechos del Paciente

AutaMedica IA — Investigador: E.M. — En fase de validación clínica ampliada